

Dermatopatología — Guía de estudio

Trastornos acantolíticos

Capítulo 5

Apuntes originales en español, redactados como material de estudio. No sustituyen al atlas ni a la observación directa de las preparaciones.

Índice

Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre él → «Actualizar campos». También puedes navegar con el Panel de navegación (Vista → Panel de navegación).

Capítulo 5 — Trastornos acantolíticos

El término acantólisis (del griego *akantha*, espina/púa, y *lysis*, disolución) designa la pérdida de cohesión entre los queratinocitos por daño de sus uniones desmosómicas, con formación de ampollas intraepidérmicas. Los queratinocitos acantolíticos se redondean y se separan, y las papilas dérmicas tapizadas por una hilera de células basales pueden proyectarse hacia la cavidad ampollosa formando "vellosidades" (villi).

El espectro de causas es amplio: trastornos hereditarios con inestabilidad desmosómica (enfermedad de Darier, enfermedad de Hailey-Hailey, por mutaciones de bombas de calcio), el grupo autoinmune del pénfigo (autoanticuerpos que dañan directamente los desmosomas) y diversas lesiones acantolíticas focales. Los desmosomas también pueden dañarse de forma secundaria por edema intenso (espongiosis) o por degeneración balonizante (infecciones víricas); estos procesos no se incluyen en la categoría acantolítica propiamente dicha.

Dado que los rasgos histológicos de muchas de estas entidades se solapan considerablemente, el diagnóstico depende de una buena información clínica y, en el grupo del pénfigo, de los estudios de inmunofluorescencia. Un eje práctico es el nivel de la acantólisis: suprabasal (pénfigo vulgar, vegetante, paraneoplásico, Darier, Hailey-Hailey) frente a subcórnea/granular alta (pénfigo foliáceo, eritematoso, fogo selvagem, IgA, Grover subcórneo).

Tabla — Antígenos diana en las variantes de pénfigo

Variante de pénfigo	Autoantígeno
Pénfigo vulgar	Dsg3 (mucoso); Dsg3 + Dsg1 (cutáneo-mucoso); también desmocolinas, plaquina, receptor de acetilcolina
Pénfigo vegetante	Dsg3; Dsc1 y Dsc2 en algunos pacientes
Pénfigo foliáceo	Dsg1
Pénfigo eritematoso	Dsg1
Fogo selvagem (endémico)	Dsg1 (rara vez también Dsg3)
Pénfigo por IgA	Dsc1; Dsg1 o Dsg3
Pénfigo herpetiforme	Dsg1, rara vez Dsg3
Pénfigo paraneoplásico	Desmoplaquinas I y II, envoplaquina, periplaquina, BP230, plectina, Dsg1 y Dsg3
Pénfigo inducido por fármacos	Dsg1 o Dsg3

A. Pénfigo

El pénfigo (del griego *pemphix*, ampolla) agrupa enfermedades ampollosas crónicas por autoanticuerpos contra proteínas desmosómicas. Es raro (incidencia 0,1–0,7/100.000/año), más frecuente en población judía (sobre todo askenazí) y en la India; sin predilección de sexo. El nivel de la ampolla y el antígeno diana definen las variantes; la regla general es que los anticuerpos anti-Dsg3 producen acantólisis suprabasal (mucosa/profunda) y los anti-Dsg1, acantólisis subcórnea (cutánea superficial), de acuerdo con la distribución de cada desmogleína (teoría de la compensación de desmogleínas).

Pénfigo vulgar (*Pemphigus vulgaris*)

Clínica: La variante más frecuente. Erosiones dolorosas en mucosa oral (a menudo la primera y a veces única manifestación durante meses), seguidas de ampollas flácidas cutáneas que se rompen dejando erosiones; signo de Nikolsky positivo. Curso crónico, potencialmente grave.

Antígeno diana: Desmogleína 3 (Dsg3) en la afectación mucosa; Dsg3 + desmogleína 1 (Dsg1) en la enfermedad mucocutánea.

Histopatología: Acantólisis suprabasal con una ampolla justo por encima de la capa basal; las células basales permanecen adheridas a la membrana basal a modo de "hilera de lápidas" (tombstone) y tapizan las papilas que protruyen ("villi"). Acantólisis que se extiende por los anexos (folículos). Escaso infiltrado, con eosinófilos variables.

Inmunofluorescencia: IFD: depósito intercelular ("en panal"/red de pesca) de IgG y C3 en la epidermis. IFI: anticuerpos circulantes anti-sustancia intercelular; ELISA anti-Dsg3 ($\pm$ anti-Dsg1) confirma y se correlaciona con la actividad.

Pénfigo vegetante (Pemphigus vegetans)

Clínica: Variante del pénfigo vulgar con placas vegetantes, hipertróficas y húmedas en pliegues (axilas, ingles, periorificial). Subtipos de Neumann (más grave, similar al vulgar) y de Hallopeau (más leve, con pústulas iniciales).

Antígeno diana: Dsg3; en algunos pacientes también Dsc1 y Dsc2 (desmocolinas).

Histopatología: Acantólisis suprabasal junto con hiperplasia epidérmica pseudoepiteliomatosa, papilomatosis y abscesos intraepidérmicos de eosinófilos (muy característicos del subtipo de Hallopeau).

Inmunofluorescencia: IFD: depósito intercelular de IgG y C3, igual que el pénfigo vulgar.

Pénfigo foliáceo (Pemphigus foliaceus)

Clínica: Ampollas muy superficiales y frágiles que rara vez se ven intactas; predominan erosiones costrosas escamosas en zonas seboreicas (cara, cuero cabelludo, tronco superior). No afecta mucosas (a diferencia del vulgar). Nikolsky positivo.

Antígeno diana: Desmogleína 1 (Dsg1).

Histopatología: Acantólisis alta, subcórnea o en la capa granular, con una ampolla superficial; pueden verse células acantolíticas y neutrófilos/eosinófilos; a veces disqueratosis granular. La capa basal no se afecta (a diferencia del vulgar).

Inmunofluorescencia: IFD: depósito intercelular de IgG/C3, a menudo más intenso en la epidermis superior. ELISA anti-Dsg1.

Pénfigo foliáceo endémico (fogo selvagem) (Endemic pemphigus foliaceus (fogo selvagem))

Clínica: Forma endémica del pénfigo foliáceo en zonas rurales de Brasil y otras regiones de Sudamérica; afecta a personas jóvenes, con agrupación familiar y geográfica, lo que sugiere un desencadenante ambiental (posiblemente picaduras de mosca negra, Simulium). Clínicamente idéntico al pénfigo foliáceo, con sensación de quemazón ("fogo selvagem" = "fuego salvaje").

Antígeno diana: Dsg1 (rara vez también Dsg3).

Histopatología: Idéntica al pénfigo foliáceo: acantólisis subcórnea/granular.

Pénfigo herpetiforme (Pemphigus herpetiformis)

Clínica: Variante con disposición herpetiforme de vesículas y pápulas pruriginosas en patrón anular, clínicamente parecida a la dermatitis herpetiforme, pero con inmunología de pénfigo.

Antígeno diana: Dsg1 (rara vez Dsg3).

Histopatología: Espongiosis eosinofílica y/o pústulas subcórneas con acantólisis escasa o focal; puede faltar la acantólisis franca.

Inmunofluorescencia: IFD: depósito intercelular de IgG, que confirma el diagnóstico pese al cuadro histológico atípico.

Pénfigo eritematoso (síndrome de Senear-Usher) (Pemphigus erythematosis)

Clínica: Solapamiento de pénfigo foliáceo y lupus eritematoso: lesiones eritematoescamosas en distribución malar/seboreica.

Antígeno diana: Dsg1.

Histopatología: Acantólisis superficial como el foliáceo.

Inmunofluorescencia: IFD: depósito intercelular de IgG/C3 más, característicamente, depósito granular en la unión dermoepidérmica (banda lúpica); pueden detectarse anticuerpos antinucleares.

Pénfigo paraneoplásico (Paraneoplastic pemphigus)

Clínica: Asociado a neoplasias (sobre todo linfoproliferativas: linfoma no Hodgkin, leucemia linfocítica crónica, enfermedad de Castleman, timoma). Estomatitis intratable y grave (rasgo dominante), lesiones cutáneas polimorfas (ampollas, lesiones liquenoides, eritema multiforme-like) y, con frecuencia, bronquiolitis obliterante (mal pronóstico).

Antígenos diana: Plaquinas (desmoplaquinas I/II, envoplaquina, periplaquina, plectina, BP230) y desmogleínas (Dsg1, Dsg3).

Histopatología: Combinación de acantólisis suprabasal con dermatitis de interfase liquenoide y queratinocitos necróticos/apoptóticos (rasgo distintivo respecto al pénfigo vulgar puro).

Inmunofluorescencia: IFD: depósito intercelular de IgG/C3 y, además, depósito en la membrana basal. IFI: anticuerpos que tiñen epitelios de transición (la vejiga de rata es un sustrato clásico positivo). Inmunoprecipitación frente al complejo de plaquinas confirma.

Pénfigo por IgA (IgA pemphigus)

Clínica: Vesículo-pústulas flácidas en disposición anular ("girnaldas"), en pliegues y tronco. Dos subtipos: dermatosis pustulosa subcórnea tipo IgA (similar a Sneddon-Wilkinson) y dermatosis neutrofílica intraepidérmica tipo IgA.

Antígenos diana: Desmocolina 1 (Dsc1) en el tipo subcórneo; Dsg1 o Dsg3 en el intraepidérmico.

Histopatología: Pústulas con neutrófilos (subcórneas o intraepidérmicas) con acantólisis escasa.

Inmunofluorescencia: IFD: depósito intercelular de IgA (no IgG), clave diagnóstica.

Pénfigo inducido por fármacos (Drug-induced pemphigus)

Clínica: Inducido típicamente por fármacos con grupos tiol (penicilamina, captopril) y otros; suele recordar al pénfigo foliáceo; puede remitir al retirar el fármaco.

Antígeno diana: Dsg1 o Dsg3.

Pénfigo de contacto (Contact pemphigus)

Clínica: Acantólisis desencadenada por contacto con agentes externos (p. ej., pesticidas, fenoles); raro.

B. Dermatosis acantolíticas con disqueratosis

Grupo caracterizado por la combinación de acantólisis y disqueratosis (queratinización anómala de queratinocitos individuales, que forman cuerpos redondos y granos). Incluye trastornos hereditarios por mutación de bombas de calcio del retículo (Darier, ATP2A2) y del aparato de Golgi (Hailey-Hailey, ATP2C1), y dermatosis adquiridas focales.

Enfermedad de Hailey-Hailey (pénfigo benigno familiar) (Hailey-Hailey disease)

Clínica: Herencia autosómica dominante. Placas eritematosas, maceradas, fisuradas y vegetantes en pliegues (cuello, axilas, ingles), que empeoran con el calor, la sudoración y la fricción; brotes recurrentes con sobreinfección. Suele iniciarse en la 2.^a-3.^a década.

Genética: Mutaciones de ATP2C1 (bomba de calcio del aparato de Golgi), lo que altera la homeostasis del calcio y la formación de desmosomas.

Histopatología: Acantólisis suprabasal extensa que afecta a casi todo el grosor de la epidermis, con aspecto de "pared de ladrillos derruida" (dilapidated brick wall); disqueratosis escasa (algún cuerpo redondo); leve infiltrado. A diferencia del Darier, la acantólisis es más amplia y la disqueratosis menor.

Inmunofluorescencia: Negativa (es hereditaria, no autoinmune) — útil para diferenciarla del pénfigo.

Enfermedad de Darier (disqueratosis folicular) (Darier's disease)

Clínica: Herencia autosómica dominante. Pápulas queratósicas pardas, grasientas y malolientes en zonas seboreicas (tórax, espalda, cuero cabelludo, frente), que confluyen en placas; empeora con el sol y el calor. Hallazgos asociados: pápulas palmares (pits), papilomatosis de mucosa oral y anomalías ungueales (bandas rojas/blancas longitudinales con muescas en "V" distales). Variante lineal/segmentaria por mosaicismo.

Genética: Mutaciones de ATP2A2 (bomba de calcio SERCA2 del retículo endoplásmico).

Histopatología: Acantólisis suprabasal focal con hendiduras suprabasales y disqueratosis prominente que forma dos cuerpos característicos: cuerpos redondos (corps ronds, en la capa espinosa-granular, con halo claro perinuclear) y granos (grains, queratinocitos disqueratósicos elongados en el estrato córneo). Papilomatosis e hiperqueratosis; villi tapizados por células basales.

Inmunofluorescencia: Negativa.

Dermatosis acantolítica transitoria (enfermedad de Grover) (Transient acantholytic dermatosis (Grover disease))

Clínica: Erupción pruriginosa de pápulas y pápulo-vesículas en tronco de varones de edad media-avanzada; desencadenada por calor, sudoración, encamamiento o exposición solar. Curso transitorio o recurrente.

Histopatología: Focos pequeños y discretos de acantólisis y/o disqueratosis con varios patrones coexistentes en la misma biopsia: tipo Darier (cuerpos redondos y granos), tipo Hailey-Hailey, tipo pénfigo vulgar (suprabasal), tipo pénfigo foliáceo (subcórneo) y tipo espongiótico. La clave es lo focal y discreto de las lesiones.

Inmunofluorescencia: Negativa.

Dermatosis acantolítica lineal recidivante (Relapsing linear acantholytic dermatosis)

Histopatología: Lesiones acantolíticas de distribución lineal (blaschkoide) y curso recurrente; histología tipo Darier/Grover focal.

C. Lesiones acantolíticas y disqueratósicas focales

Enfermedad de Darier lineal (Linear Darier's disease)

Clínica: Forma segmentaria/lineal de la enfermedad de Darier por mosaicismo postcigótico de ATP2A2; sigue las líneas de Blaschko.

Histopatología: Idéntica a la enfermedad de Darier (cuerpos redondos y granos, acantólisis suprabasal), limitada a la banda afectada.

Dermatosis acantolítica del área genitocrural (Acantholytic dermatosis of the genitocrural area)

Clínica: Lesiones papulosas acantolíticas localizadas en región genital, perineal o inguinal; entidad benigna, a veces llamada "enfermedad de Hailey-Hailey papular" o dermatosis acantolítica genital.

Histopatología: Acantólisis focal con disqueratosis variable, sin trasfondo hereditario generalizado.

Comedones disqueratósicos familiares (Familial dyskeratotic comedones)

Clínica: Comedones diseminados de herencia autosómica dominante.

Histopatología: Invaginaciones foliculares dilatadas con tapón de queratina y disqueratosis acantolítica en su pared.

Disqueratoma verrugoso (Warty dyskeratoma)

Clínica: Pápulo-nódulo solitario con tapón central queratósico, sobre todo en cabeza y cuello de adultos; benigno. Clínicamente puede simular un carcinoma o una verruga.

Histopatología: Invaginación copular con tapón de queratina; en su interior, acantólisis suprabasal con villi y abundante disqueratosis (cuerpos redondos y granos) — "Darier en una lesión solitaria". Conexión con un folículo.

Acantoma acantolítico (Acantholytic acanthoma)

Clínica: Pápula o nódulo queratósico solitario, en general en el tronco de adultos mayores; benigno y asintomático.

Histopatología: Acantosis con acantólisis prominente a varios niveles, sin disqueratosis significativa; lesión bien delimitada.

Acantoma disqueratósico acantolítico (Acantholytic dyskeratotic acanthoma)

Histopatología: Como el acantoma acantolítico pero con disqueratosis añadida (cuerpos redondos y granos); lesión solitaria benigna.

Disqueratosis acantolítica focal (Focal acantholytic dyskeratosis)

Concepto: Patrón histológico (no una enfermedad en sí) consistente en un foco de acantólisis con disqueratosis (cuerpos redondos y granos), que puede aparecer de forma incidental en el seno de lesiones muy diversas (melanocíticas, epiteliales, etc.) o como hallazgo aislado. Reconocerlo evita sobrediagnósticos.

Tablas de alto rendimiento

Tabla — Nivel de acantólisis e inmunofluorescencia

Entidad	Nivel de acantólisis	IFD	Antígeno / gen
Pénfigo vulgar	Suprabasal	IgG/C3 intercelular	Dsg3 ($\pm$ Dsg1)
Pénfigo vegetante	Suprabasal + hiperplasia	IgG/C3 intercelular	Dsg3
Pénfigo foliáceo / fogo selvagem	Subcórnea / granular	IgG/C3 intercelular alto	Dsg1
Pénfigo eritematoso	Subcórnea	Intercelular + banda lúpica	Dsg1
Pénfigo paraneoplásico	Suprabasal + interfase	Intercelular + membrana basal	Plaquinias + Dsg
Pénfigo por IgA	Subcórnea/	IgA intercelular	Dsc1 / Dsg

	intraepidérmica		
Hailey-Hailey	Suprabasal amplia ("pared derruida")	Negativa	ATP2C1 (Golgi)
Darier	Suprabasal focal + disqueratosis	Negativa	ATP2A2 (SERCA2)
Grover	Focal, patrones mixtos	Negativa	—

Tabla — Darier vs Hailey-Hailey vs Grover

Rasgo	Darier	Hailey-Hailey	Grover
Acantólisis	Suprabasal focal	Suprabasal extensa	Focal, pequeña
Disqueratosis	Prominente (cuerpos redondos y granos)	Escasa	Variable según patrón
Distribución clínica	Zonas seborreicas	Pliegues	Tronco
Gen	ATP2A2	ATP2C1	—
Curso	Crónico	Crónico recurrente	Transitorio/recurrente

Tabla — Teoría de la compensación de desmogleínas

Anticuerpo	Mucosa	Piel	Resultado clínico
Anti-Dsg3 solo	Dsg3 dominante (poca Dsg1)	Dsg1 compensa	Pénfigo vulgar mucoso
Anti-Dsg3 + anti-Dsg1	Sin compensación	Sin compensación	Pénfigo vulgar mucocutáneo
Anti-Dsg1 solo	Dsg3 compensa	Dsg1 superficial dominante	Pénfigo foliáceo (solo piel superficial)

Glosario bilingüe (inglés → español)

Término (EN)	Español	Nota
Acantholysis	Acantólisis	Pérdida de cohesión entre queratinocitos
Desmosome	Desmosoma	Unión intercelular dañada en estos trastornos
Desmoglein (Dsg1/Dsg3)	Desmogleína	Cadherina desmosómica; diana del pénfigo
Desmocollin (Dsc)	Desmocolina	Diana del pénfigo por IgA
Suprabasal cleft	Hendidura suprabasal	Sobre la capa basal (Darier, pénfigo vulgar)
Tombstone row	Hilera de lápidas	Células basales adheridas a la membrana basal
Villi	Vellosidades (villi)	Papilas tapizadas por basales en la cavidad
Corps ronds / grains	Cuerpos redondos / granos	Disqueratosis de la enfermedad de Darier
Dilapidated brick wall	Pared de ladrillos derruida	Hailey-Hailey
Net-like / intercellular	En red / intercelular	Patrón IFD del pénfigo
Nikolsky sign	Signo de Nikolsky	Desprendimiento epidérmico con presión
Eosinophilic spongiosis	Espongiosis eosinofílica	Fase precoz (pénfigo herpetiforme/vegetante)
Plakins	Plaquinas	Dianas del pénfigo paraneoplásico
ATP2A2 / ATP2C1	ATP2A2 / ATP2C1	Bombas de calcio (Darier / Hailey-Hailey)

Nota: documento de elaboración propia con fines de estudio.